



産褥期
(子宮復古不全・産褥熱・
乳腺疾患、
メンタルヘルス)

2026年7月27日(月) 1限
産科婦人科学
北折 珠央

産褥期

産褥期(Puerperium)
分娩後6~8週間

妊娠・分娩により母体は解剖学的・生理学的に大きな変化をきたす。

分娩後から再び非妊娠時の状態に戻るまでの期間をいう



待望の赤ちゃんが生まれてHappy!

、、、だけではない現実（心身共）
それが産褥

産褥・・・。「褥」

かなり古い時代から出産や月経は穢れとされてきた思想

気 枯れ（け がれ）

「気」＝「気の象徴である血」が
「枯れる」

が語源だが、次第に、血を流すこと→「穢れ」
とされるようになった
（らしい）

産褥期の問題点

<生 理>

子宮復古

乳汁分泌

<病 理>

子宮復古不全

産褥熱

乳汁分泌不全

乳汁うっ滞・乳腺炎

産褥精神障害

産褥期の入院管理

入院期間： 自然分娩（産後5日）

帝王切開（術後5日間）（名市大病院では）

※アメリカでは自然分娩では初産婦48時間、経産婦24時間

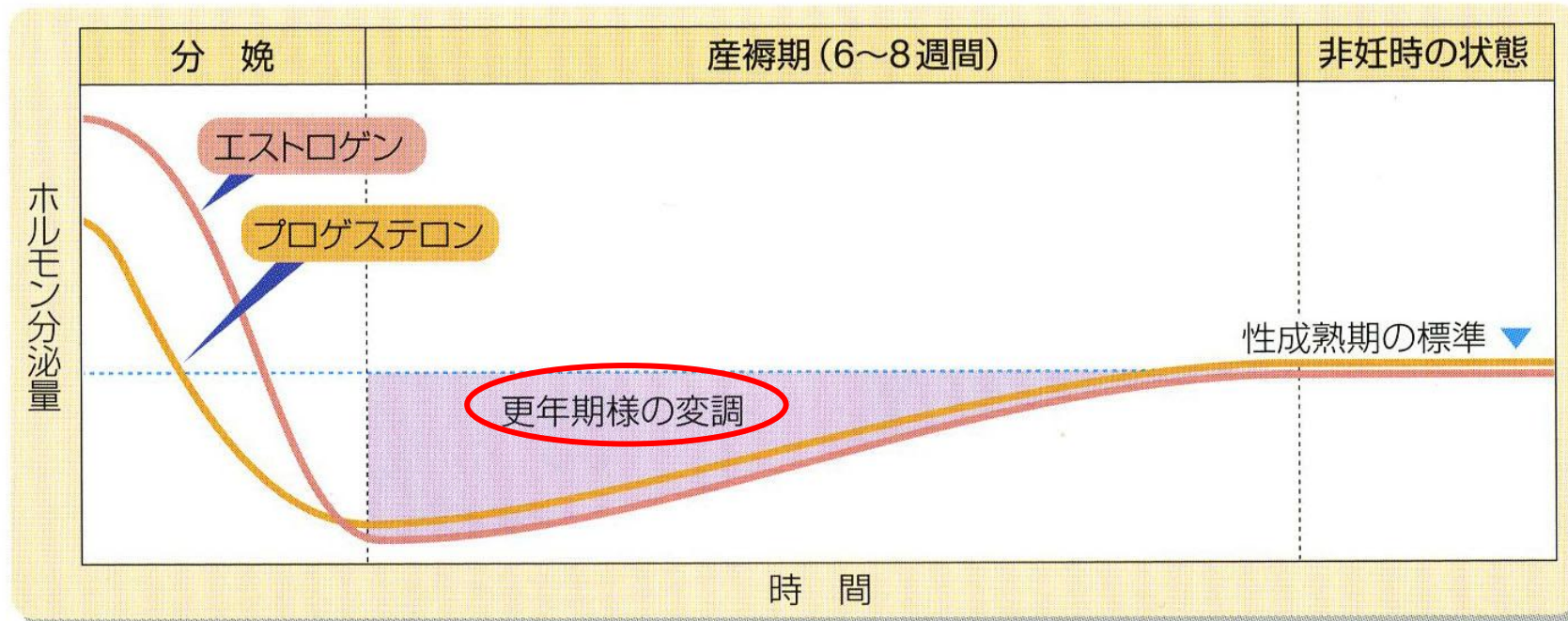
母	離 床	● 血栓形成の防止
	産褥体操	● 血栓形成の防止 ● 美容 ● 悪露排出の促進 ● 血流促進による疲労回復 ● 乳汁分泌促進
	導 尿	● 膀胱充満が弛緩出血の原因となるため
	母子同室	● 母子の絆を強めるため、なるべく早い段階で同室とするのが理想.
	シャワー	● 悪露や乳汁を洗い流す
児	吸 引	● 口腔，鼻腔，咽頭の羊水を吸引
	点 眼	● 淋菌やクラミジアの産道感染による新生児膿漏眼を防ぐ
	ビタミンK ₂ シロップ	● ビタミンK 欠乏症の予防

産褥の生理(内分泌系)



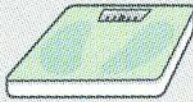
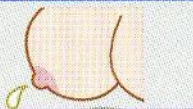
分娩後の母体変化 産褥の概観

- 産褥とは、妊娠・分娩によって変化した母体が再び非妊時の状態に戻るまでの期間をいい、分娩後6～8週間までのことを指す。
- 産褥期では、妊娠中に通常の数百倍まで上昇したエストロゲン、プロゲステロンが、分娩を機に急激に減少する。これにより、一時的にいわば更年期様の変調をきたす。



産褥の生理(身体所見)

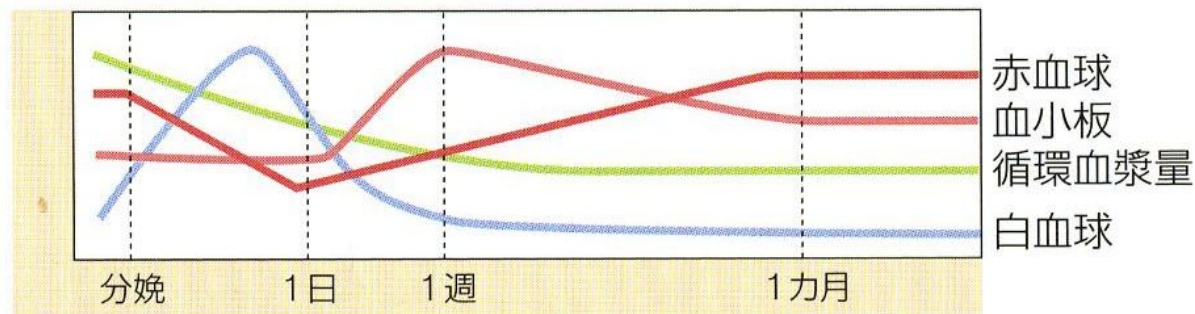
主な変化

全身的变化	発汗		● 発汗が増加する.
	体温		● 産褥3日頃まで37～37.5℃を示すが、4日以降は平熱に戻る. ● 38℃以上の発熱は産褥熱を疑う
	体重		● 胎児、胎盤の娩出、羊水の排出、出血、発汗などにより約5.5kg減少する. ● 2～4カ月かけてさらに約4kg減少して非妊時の体重に戻る. ● しかし、妊娠による皮下脂肪の蓄積により非妊時より2～3kg増加することが多い.
	精神		● マタニティーブルーズ、産褥期精神病
局所的变化	乳房		● 経産婦では産褥1～2日頃、初産婦では産褥2～3日頃から乳汁分泌が開始する.
	子宮		● 分娩後子宮は急速に収縮して復古する.
	膣		● 萎縮性膣炎様

産褥の生理(血液・循環器系)



血液と循環器系の変化(イメージ)



血液	赤血球	● 分娩時の出血で減少するが、産褥1カ月までに非妊時の値まで回復する。
	白血球	● 分娩時から増加、分娩直後から著増する(約15,000/ μ L)が、その後急速に減少し、産後1週間で非妊時に近い値まで下がる(非妊時の値まで下がるのは産後1カ月)。
	血小板	● 分娩時の出血によって減少するが、産褥期の出血に備えその後増加する。このため、 <u>血栓症が好発する</u>
循環器系	● 分娩時には頻脈や血圧上昇をきたすが、多くは産褥0~1日で非妊時の値に戻る。 ● 循環血漿量は分娩時の出血や産褥期の発汗増加、悪露などによって徐々に減少し、産褥3週までに非妊時のレベルに戻る。	

後陣痛(afterpains)

子宮復古に伴う痛み

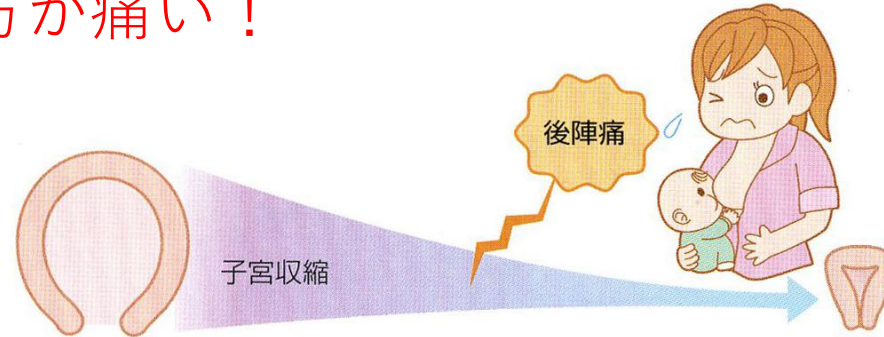
後陣痛

- 子宮復古を促すための不規則な子宮収縮を後陣痛という
- これは胎盤剝離面からの出血を止め、子宮を元の大きさに戻すための生理現象である

経産婦の方が痛い！

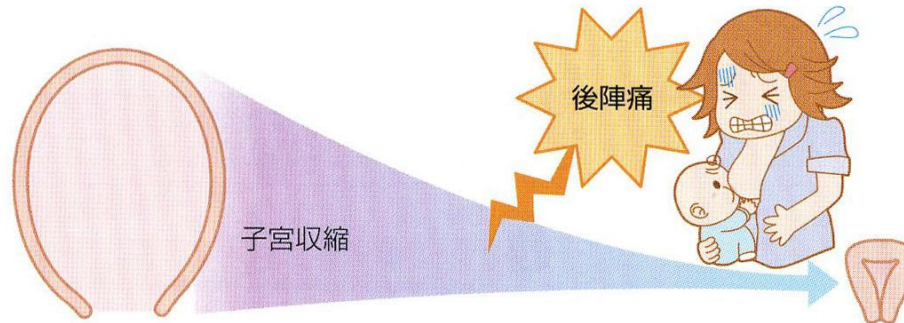
正常妊娠の場合(初産)

- 妊娠により増大した子宮を、後陣痛で元の大きさまで縮小させる。



経産婦, 多胎妊娠, 羊水過多症の場合

- 正常妊娠よりも子宮の増大または疲労の程度が大きいため、強い収縮が必要となり、より強力な後陣痛が起こる。



- 乳汁を放出する作用をもつオキシトシンというホルモンには、後陣痛を促進する作用もある。
このため、オキシトシンの分泌が亢進する授乳時には後陣痛が増強される

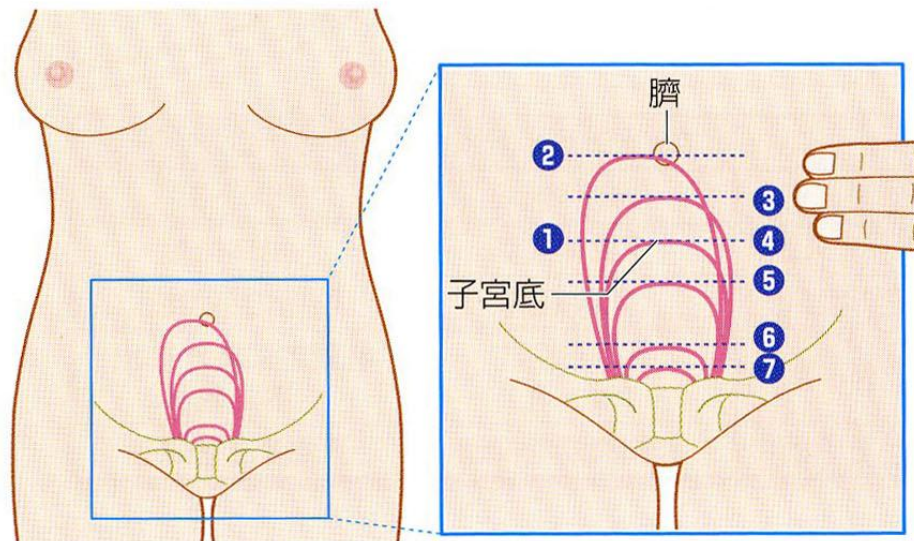
子宮復古



一度上昇してから下降する

子宮底の高さの経時変化

- 子宮復古に伴い、子宮底の位置が経時的に変化する。
- 胎盤娩出後、子宮底は臍下2～3横指の位置にあるが、弛緩した骨盤底筋群の回復と膀胱の充満により徐々に上昇する。分娩12時間後には一時臍高にまで達するが、その後は徐々に下降し、産褥6～8週で非妊時の子宮の大きさに戻る。
- 産褥2週間経過しても腹壁上から子宮底を触知できる場合や、産褥6週で子宮の大きさが鶏卵大以上であれば、子宮復古不全を考える。



経過時間	子宮底の高さ	子宮底長
① 分娩直後	臍下3横指	11cm
② 分娩後12時間	臍高(右に傾く)	15cm
③ 産褥1～2日目	臍下1～2横指	12cm
④ 産褥3日目	臍下3横指	10cm
⑤ 産褥5日目	臍高～恥骨結合上縁の中央	9cm
⑥ 産褥7日目頃	恥骨結合上縁	
⑦ 産褥10日目以降	腹壁上から触れない	

子宮復古とおろ



復古現象の過程でみられる

子宮復古とお露

- 妊娠・分娩によって変化した子宮が非妊時の状態に復帰することを子宮復古という。
- 子宮復古は、子宮の胎盤・卵膜剝離面に生じた多数の血管の断端面を圧迫して止血する役目をする（生物学的結紮）
- 産褥中に子宮腔内から排出される分泌物を^{おろ}悪露という。
- 悪露は胎盤・卵膜剝離面からの血液や分泌物が主体である。

産 褥		2, 3日	1週頃	2, 3週頃	4週頃	6週頃
子宮体部	形状	子宮復古の期間 				
	重さ	約1,000g	約500g	約300g	約100g	約70g
子宮頸部 (外子宮口)		2指分 開いている	1指分 開いている		閉鎖	
悪 露		赤色 ● 血液成分が多く含まれる。	褐色 ● ヘモグロビン が変性し、褐 色を呈する。	淡黄色 ● 血液成分は減 少し、白血球 が主体となる。	白色 ● 白血球は減少 し、子宮腺分 泌液が主体と なる。	消失

- 血性の悪露が2週間以上続く場合は、胎盤遺残などによる子宮復古不全を考える
- 子宮復古は後陣痛によって促進される

子宮復古不全

intro.

産褥期に種々の原因で子宮の収縮が不良となり、そのため子宮の復古（退縮）が障害された状態をいう。原因は胎盤、卵膜などの子宮腔内遺残によることが多い。

MINIMUM ESSENCE

subinvolution of the uterus

- ①産褥2週間を経ても、
 - ②血性悪露^{おろ}が持続し、
 - ③産褥日数に比較して、子宮が大きくかつ軟らかく、
 - ④超音波検査にて、子宮腔内に遺残物が認められたとき、
- 子宮復古不全 を考える。

〈子宮の収縮不良〉

治療 原因を検討し、適切な治療法を選択する。

- 胎盤遺残などがある場合、子宮内容除去術を行い、子宮収縮促進薬を投与する。

※感染徴候がある場合は、抗菌薬の投与を行う。

- 子宮復古不全の原因は、弛緩出血とほぼ共通である
- 血性悪露が続くため、子宮内膜炎や子宮筋層炎などの子宮内感染を起こしやすい



子宮復古不全の原因

子宮復古不全の原因は子宮収縮を妨げる明らかな原因を認める器質性とこれらを認めない機能性の2種類に分類される。

①器質性子宮復古不全

- a. 胎盤や卵膜など胎児付属物の子宮腔内遺残
- b. 悪露の子宮腔内滞留
- c. 子宮筋腫
- d. 子宮内膜炎，子宮筋層炎などの子宮内感染など

②機能性子宮復古不全

- a. 多胎妊娠，巨大児，羊水過多症などによる子宮筋の過度の伸展による疲労
- b. 微弱陣痛
- c. 塩酸リトドリンなどの子宮収縮抑制薬の長期使用
- d. 授乳をしないこと
- e. 母体疲労
- f. 過度の安静
- g. 膀胱や直腸の慢性的充満など

子宮復古不全の治療

①一般療法

- a. 早期離床（過度の安静回避）
 - b. 母乳授乳促進
 - c. 冷罨法
 - d. 子宮底マッサージ
 - e. 排便・排尿の促進
- など

②薬物療法（子宮収縮薬）

a. 麦角アルカロイド薬

持続的強直性子宮収縮をもたらし、子宮復古不全の子宮収縮薬としては第一選択となる。

- b. プロスタグランジン
- c. オキシトシン

産褥熱

intro.

分娩時や産褥期において、性器や子宮に生じた創傷からの細菌感染によって発症した熱性疾患の総称である。わが国では、分娩後24時間から産褥10日までの間に38℃以上の発熱を2日以上きたすものをいう。

MINIMUM ESSENCE

puerperal fever

- ① 分娩後24時間～産褥10日目までに、
 - ② 2日以上にわたって38℃以上の発熱が続き、
 - ③ 下腹痛、子宮傍組織への圧痛、悪臭を伴う悪露などを認め、
 - ④ 血液検査にて、CRP ↑、WBC ↑を示したとき、
- 産褥熱 と診断する。

治療 原因菌の同定ができるまで、広域スペクトルを有する抗菌薬（クリンダマイシン、ゲンタマイシンなど）を投与する。

※胎盤・卵膜の遺残がある場合、子宮内容除去術を行う。

- 一般に子宮内膜炎を原因とするものを産褥熱として扱い、性器や子宮以外の感染（腎盂腎炎、乳腺炎など）に由来する発熱は産褥熱には含まない。
- 以前は妊産婦死亡の重要な原因であったが、先進国では分娩の管理や帝王切開後の予防的抗菌薬投与などにより、産褥熱による死亡は1%以下にまで減少した。
- 正常の褥婦でも産褥4日頃までは、37～37.5℃程度の体温上昇はみられる

産褥熱の原因・誘因



分娩前	前期破水（24 時間以上経過） 産道に対する器械的操作，頻回の内診 細菌性膣症， <u>絨毛膜羊膜炎</u> 切迫早産 抗生物質の長期投与
分娩中	<u>産科手術</u> （帝王切開，胎盤用手剥離） 遷延分娩 早産，死産 大量出血
産褥期	産道に対する機械的操作，頻回の内診 <u>子宮内遺残</u> （胎盤，卵膜，ガーゼ） 低栄養状態
母体合併症	妊娠中毒症 糖尿病，自己免疫疾患 免疫力低下（ステロイドホルモン服用， HIV 感染症） 子宮筋腫（悪露滞留）

産褥性無月経

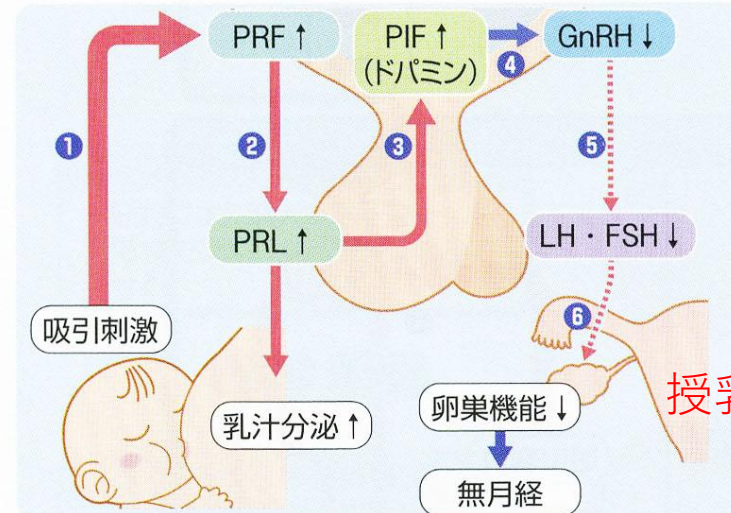


授乳婦は月経再開が遅れる

産褥性無月経

授乳と無月経の関係

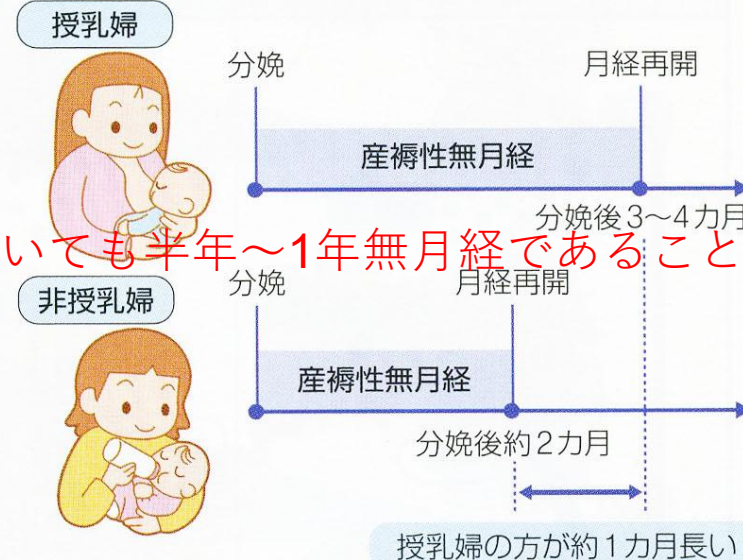
- 無月経はプロラクチンの卵巢機能抑制作用によって起こる。



- ① 児の吸引刺激によるプロラクチン放出因子 (PRF) の分泌亢進
- ② PRL 分泌亢進
- ③ 短環フィードバックによる、視床下部からのプロラクチン抑制因子 (PIF [ドパミン]) の分泌亢進
- ④ ギナドトロピン放出ホルモン (GnRH) の分泌抑制
- ⑤ LH・FSH の分泌抑制
- ⑥ エストロゲン・プロゲステロンの分泌抑制

産褥性無月経の期間

- 無月経の期間は授乳の有無により大きく左右される
- 非授乳婦では吸引刺激がないため、プロラクチンの卵巢機能抑制作用が比較的弱い。このため卵巢機能回復が早く、無月経の期間が短くなる。



授乳していても半年～1年無月経であることが多い

- 分娩後の初回月経は、無排卵性月経のことが多い。ただし、月経発来前に排卵を認めることもあり、妊娠することもある。

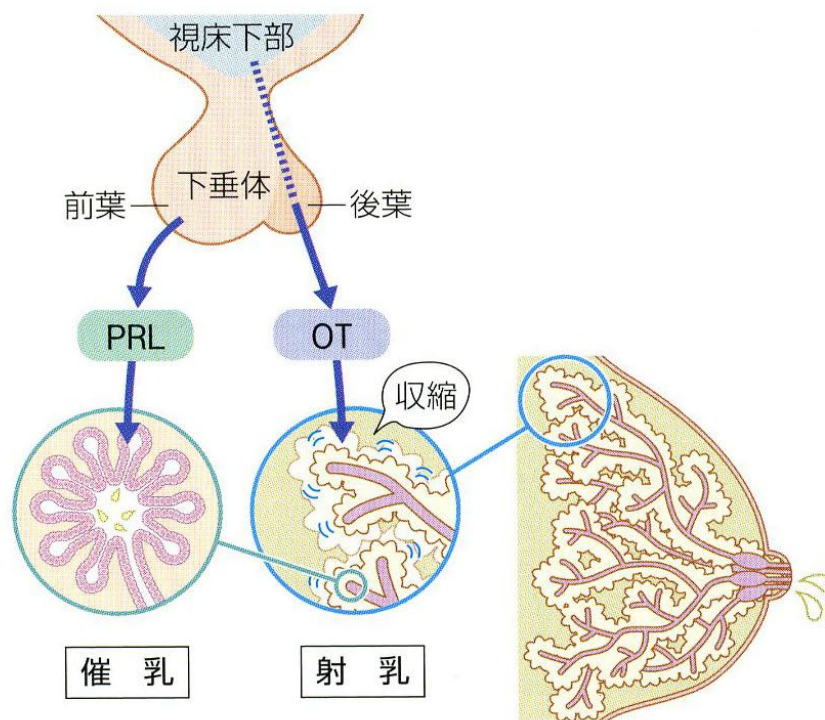
授乳とホルモン



乳汁に関連するホルモン

プロラクチン (PRL) とオキシトシン (OT)

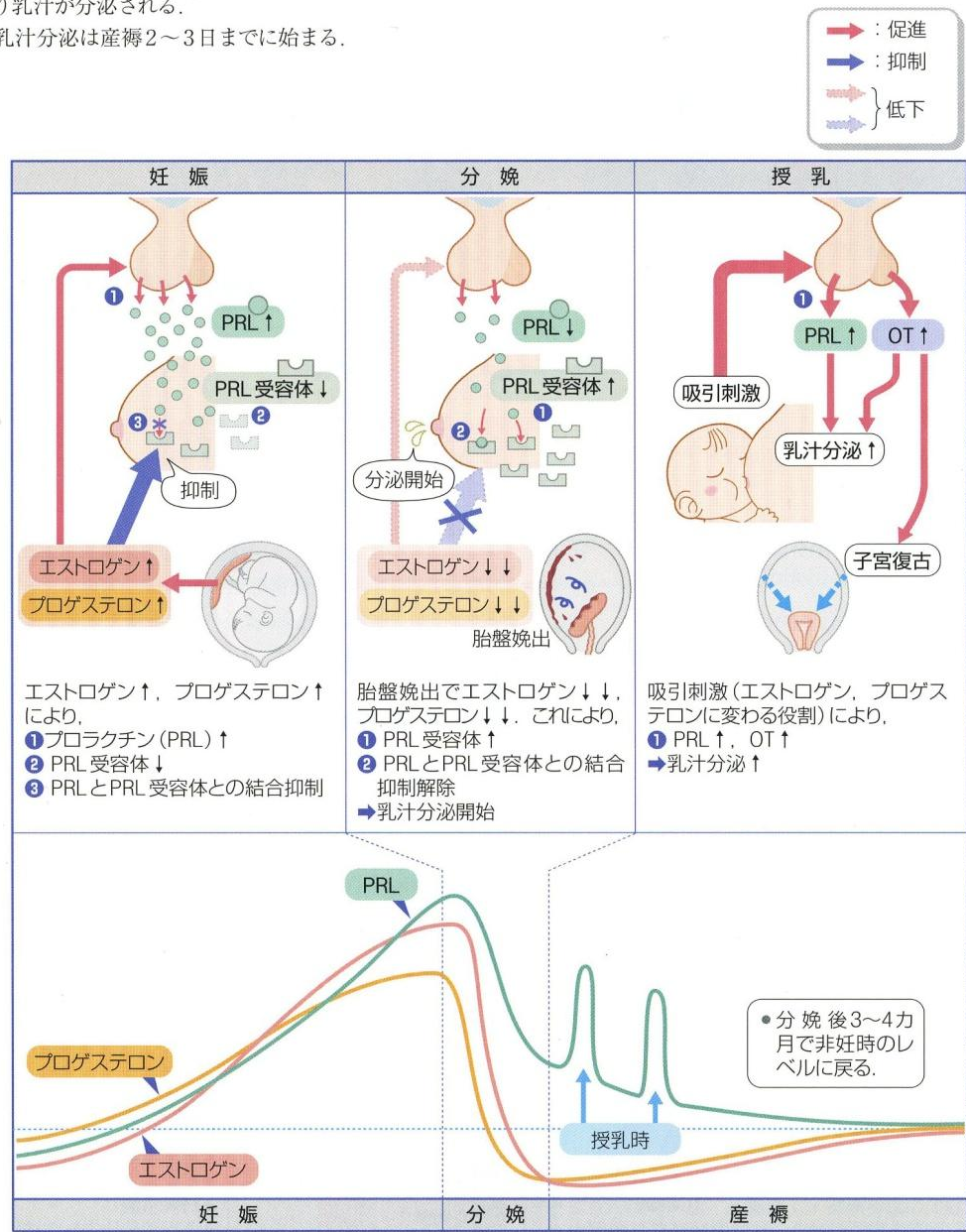
- 乳汁分泌では主に下垂体ホルモンであるプロラクチンとオキシトシンが関与している
- 両ホルモンともに乳汁分泌に重要な役割を担い (vol.9 : 198頁), 児の吸引刺激によって分泌が亢進するという特徴をもっている



プロラクチンとオキシトシンの比較

	プロラクチン (PRL)	オキシトシン (OT)
産 生	下垂体前葉	視床下部
分 泌	下垂体前葉	下垂体後葉
作用部位	乳腺細胞	腺房の平滑筋
作 用	乳汁産生 ↑ (催乳)	乳管内に乳汁放出 (射乳)
その他	卵巣機能を抑制	子宮復古を促進

- 分娩後、エストロゲン、プロゲステロンの乳腺に対する乳汁分泌抑制作用が解除され、プロラクチンの作用が主体となり乳汁が分泌される。
- 乳汁分泌は産褥2～3日までに始まる。



乳汁分泌機構

分娩（胎盤娩出）により
 エストロゲン、プロゲステロンの乳腺に対する乳汁分泌抑制作用が解除されることにより
 プロラクチンの作用が主体となり乳汁が分泌される

- 基本的にプロラクチン分泌のピークは妊娠末期であるが、授乳時には瞬間的に上昇する（プロラクチンサージ）。

乳汁分泌不全の原因

①中枢性乳汁分泌不全

精神的ストレス，異常出血，Sheehan 症候群などによって下垂体機能に障害をもたらし，プロラクチン低値によって乳汁分泌不全が生じたもの。

②末梢性乳汁分泌不全

乳腺組織の発育不全によって乳汁の産生が抑制されている場合や陥没・扁平乳頭などによって乳管からの乳汁排出が障害されたもの。

③児性乳汁分泌不全

児の吸啜力の不足や口腔の異常によって哺乳障害があり，結果的に乳汁分泌不全となったもの。

④社会性乳汁分泌不全

褥婦が仕事の都合などで母乳哺育への意欲がないなど社会的要因によるもの。

乳汁分泌不全の予防・治療

妊娠中

乳頭の形態チェック：陥没・扁平乳頭では妊娠中からマッサージを行う（ただし子宮収縮を誘発するので切迫早産には注意）
乳房マッサージ（乳輪を柔軟にする）

分娩後

初回哺乳を分娩後 30 分以内に開始

頻回に授乳を試みる

（授乳することでオキシトシン↑、児も慣れる）

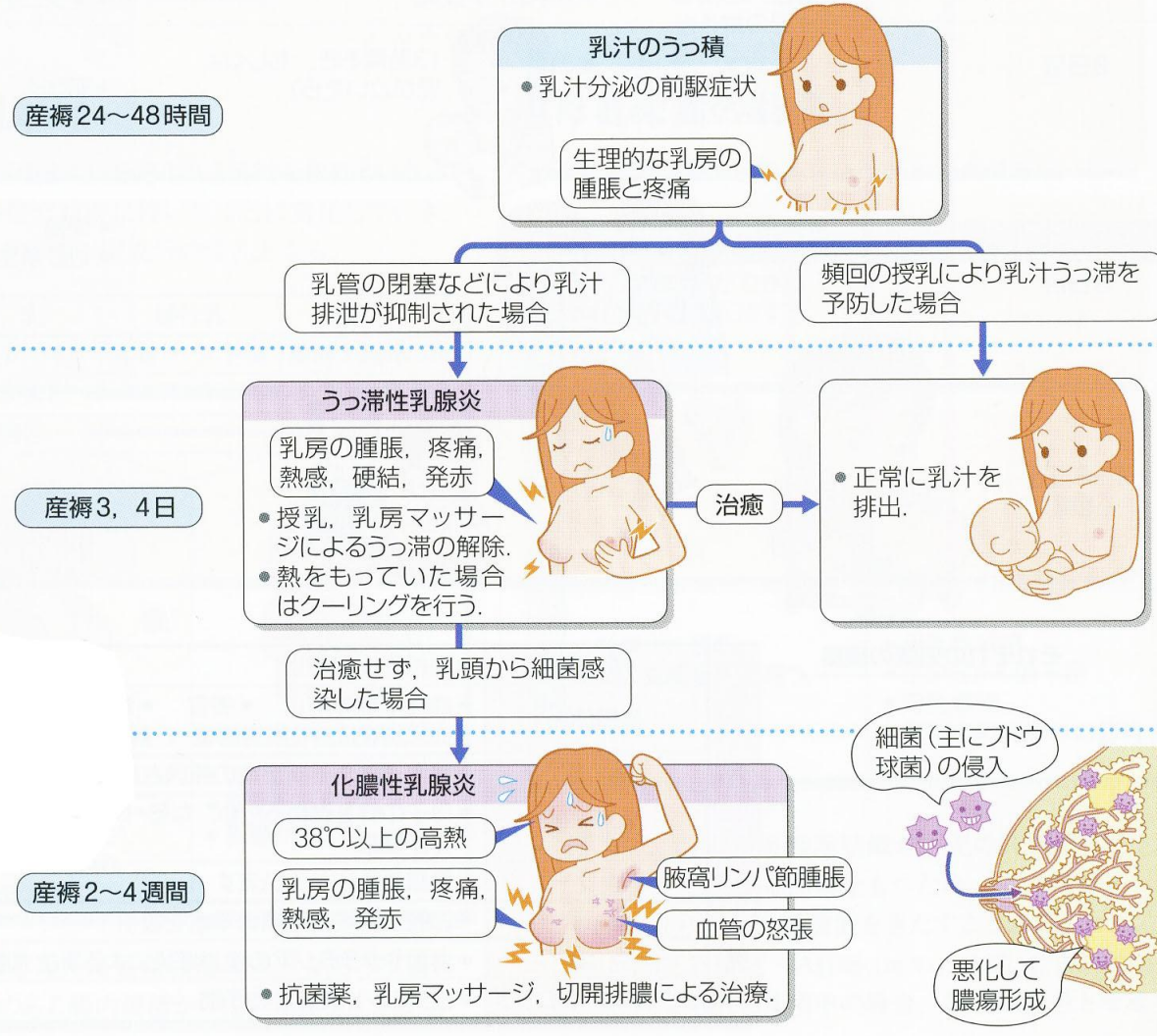
薬物療法（日本ではあまり行わない）

メトクロプラミド、スルピリド、オキシトシン

産褥乳腺炎

乳汁分泌に伴う異常 産褥乳腺炎

- 産褥でみられる乳腺の炎症を、産褥乳腺炎という。
- 産褥乳腺炎には、うっ滞性乳腺炎、化膿性乳腺炎があるが、うっ滞性乳腺炎は乳汁が何らかの原因により乳腺内に留まってしまうことで起こる生理的現象であって、真の炎症ではない。



化膿性乳腺炎：
40度近い高熱、乳房の疼痛・発赤、硬結に加え、インフルエンザ様の全身倦怠感、関節痛など。

母乳（初乳と成乳）



成分が異なる

初乳と成乳

- 分娩後（産褥）3日頃までに分泌される乳汁を初乳という。
- 母乳は新生児の発育状況に伴い日ごとに変化していき、初乳から移行乳を経て一定成分の成乳となる。

	初 乳	移行乳	成 乳
分泌時期	産褥3～5日	産褥6～14日頃	産褥2週間以降
色 調	黄～淡黄色	白 色	
性 質	粘稠性	漿液性	
特 徴			
	● 児の免疫機能を補う。 ● 免疫物質（IgA、リゾチーム、トランスフェリンなど）が多い。 ● ミネラルが高い。 ● 蛋白質が多い。		● 児の発育成長を促す。 ● エネルギーが高い。 ● 脂肪が多い。 ● 乳糖が多い。

- 母乳中に含まれるIgAは免疫機能の未熟な児の小腸に留まり、病原性のある腸内細菌から児を守る働きをもつ。

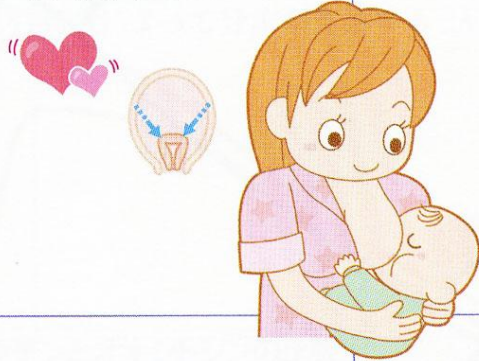


母乳栄養

母乳の利点, 欠点

母乳栄養の特徴

- 母乳栄養には以下のような利点と欠点がある.

	利 点	欠 点
授 乳	● 母児間の絆ができる. ● 子宮復古を促進する. 	
成 分	● 栄養価に富む. ● 児の免疫機能を補う.	● 母乳性黄疸 ● ビタミンKの不足 ● 母乳感染 ● 薬剤の母乳中への移行

- 母乳中に含まれる遊離脂肪酸が, 児の肝臓でのビリルビン代謝を阻害する作用をもつため, 児は高ビリルビン血症となり, 母乳性黄疸をきたすことがある.
- 乳癌, HIV 感染症・AIDS (178頁), ATL 合併妊娠
特殊な薬剤を使用中の場合, 授乳は禁忌となる.

授乳に関する注意点は？



CQ314 授乳に関する注意点は？

Answer

1. 直接授乳が困難な場合は搾母乳を勧める。(C)
2. 以下の場合、母乳栄養の中止を勧める。(B)
 - ・母親が HIV 感染症
 - ・新生児が古典的ガラクトース血症
3. 乳汁分泌抑制にあたっては禁忌に該当しないかを確認して、乳汁分泌抑制薬を使用する。(C)
4. 乳房腫脹、疼痛、発熱などを訴えた場合、乳房緊満、乳腺炎、あるいは、乳腺膿瘍を鑑別する。(B)
5. 乳房緊満予防のため、出産後早期の授乳開始や授乳指導を行い、乳汁分泌を促す。(C)
6. 乳腺炎に対しては
 - 1) 搾乳や消炎鎮痛薬投与等を行う。(C)
 - 2) 24 時間以内に症状が改善しない場合や、急速に症状が悪化する場合には、抗菌薬を投与する。(B)
 - 3) 長時間乳腺炎症状が持続した場合や症状が強い場合は細菌培養を行う。(B)
7. 乳腺膿瘍に対しては穿刺あるいは皮膚切開で排膿する。(B)
8. 難治性の乳腺炎や乳腺膿瘍の場合、MRSA 感染症や悪性腫瘍の可能性を検討する。(B)

授乳と薬剤、児への影響



CQ104-5 授乳中に使用している医薬品の児への影響について尋ねられたら？

Answer

1. 本 CQ 表 1 の A のような例外を除き、授乳婦が使用している医薬品が児に大きな影響を及ぼすことは少ないと説明する。(B)
2. 児への影響とともに、医薬品の有益性・必要性および授乳の有益性についても説明し、母乳哺育を行うか否かの授乳婦自身の決定を尊重し支援する。(B)
3. 個々の医薬品については、本 CQ 表 1、国立成育医療研究センター「妊娠と薬情報センター」などの専門サイトや専門書を参照して、説明する。(C)
4. 本 CQ 表 1 の B の医薬品を使用している授乳婦に対しては、児の飲み具合、眠り方、機嫌、体重増加などを注意するように勧める。(C)

ほとんどの場合、薬剤が母乳栄養している児に大きな影響を与えない。

薬の有益性や必要性、授乳の有益性について説明し、母乳哺育を行うか否かは授乳婦自身の決定を尊重し支援する。

授乳婦へ投与禁止、慎重投与の薬剤

(表 1) 授乳婦へは投与すべきでない、あるいは慎重に投与すべき医薬品

A. 投与禁止	1) 抗悪性腫瘍薬：少量であっても cytotoxic であり，抗悪性腫瘍薬使用中の授乳は原則禁止とすべきである．ただ，授乳をした場合に，実際に児にどのような事象が観察されたかのデータは非常に少ない．抗悪性腫瘍薬使用で授乳を強く希望する場合には個別に検討する． 2) 放射性ヨウ素など，治療目的の放射性物質：放射性標識化合物の半減期から予想される背景レベルまでの減衰にかかる期間までは授乳を中止する． 3) アミオダロン（抗不整脈薬）：母乳中に分泌され，児の甲状腺機能を抑制する作用がある．
B. 慎重投与	1) 抗てんかん薬：フェノバルビタール，エトスクシミド，プリミドン，ラモトリギンでは，RID が 10% あるいはそれ以上に達する．他剤への変更を考慮する． 2) 抗うつ薬：三環系抗うつ薬と SSRI の RID が一般に 10% 以下であり，児への大きな悪影響は見込まれない．ただ，fluoxetine と doxepin（共に日本で未市販，ネット購入可能）で，児への有害事象（腹痛発作と傾眠傾向）発生の症例報告がある． 3) 炭酸リチウム：児での血中濃度が高くなりやすいが乳汁濃度や児の血中濃度を調べて判断する． 4) 抗不安薬：ジアゼパムの長期投与において，児の傾眠傾向と体重増加不良が報告．アルプラゾラムの突然の中止で，児の離脱症候群が報告． 5) オピオイド：特定の遺伝子型の母の授乳により，児のモルヒネ中毒が起こることがある．リン酸コデイン（中枢性麻薬性鎮咳薬）含め全てのオピオイドの 3 日間以上の授乳中の使用を避ける． 6) 無機ヨウ素：乳汁中に濃縮され，乳児の甲状腺機能低下症の原因となりうる．
C. 乳汁分泌低下	カベルゴリン，エルゴタミン，プロモクリプチン，経口避妊薬，など．

RID : relative infant dose 相対的乳児投与量 (%) = $\frac{\text{経母乳的に摂取される総薬物量 (mg/kg/日)}}{\text{当該薬物の児への投与常用量 (mg/kg/日)}} \times 100$

といってもほとんどの薬剤で母乳栄養可
抗がん剤ですら授乳可とする報告も最近ある。



産後に悪化する疾患

自己免疫性疾患

SLE

関節リウマチ

重症筋無力症 など

ほとんどの例で悪化することが多い

骨粗しょう症（授乳による）



産後のメンタルヘルス

2017年4月14日 毎日新聞

妊産婦自殺

10年で63人・・・東京23区 産後うつ影響か

自殺で亡くなった妊産婦が東京23区で2005年からの10年間に計63人にのぼることがわかった。

出産数に占める割合は10万人あたり8.5人となり、
出血などによる妊産婦死亡の2倍に上る。

(妊産婦死亡は4.1人/10万人)

妊娠・出産期の死亡として自殺が一番多いことになり、
メンタルケアの充実などが急がれる。

核家族化、高齢出産増加による祖父母の高齢化など
育児支援が乏しくなっている現代で増加する可能性

是非！知ってもらいたい！！

「産後の生活はHappyなだけではない！」

24時間当直状態が数か月～1年は続きます！

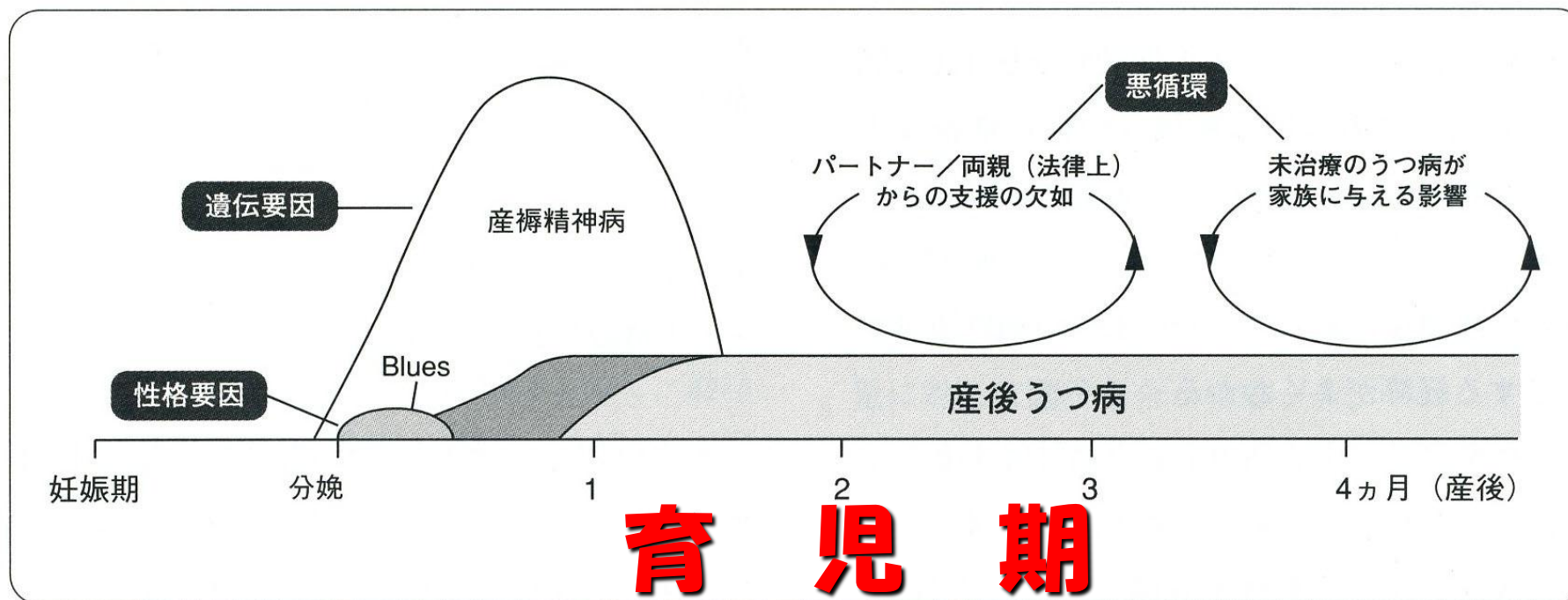
- ・ 1～3時間おきの授乳 1回の授乳も30分以上かかることも。
- ・ 赤ちゃんもすぐに上手に飲めず、途中で吐いたり排便したり寝たり、、、
- ・ 頻回なおむつ交換 排尿は1日に10数回、排便も1～10回も
- ・ 一人で生きていけない存在をケアする不安・緊張
- ・ 自分のタイミングでトイレにも行けない、食事もとれない
- ・ 赤ちゃんの意思表示を読み取れているのか自信がもてない

これらによる極度の睡眠不足
(連続した睡眠が3時間以内とれるかどうか)
急な環境の変化による精神疲労・緊張感・不安
ホルモンバランスの乱れ

産後の肉体的・精神的不安はかなり大きい（環境や個人差も大きい）



産後精神疾患のタイムコース



産後うつ病の原因と継続要因 (Cox, 1998 改変)

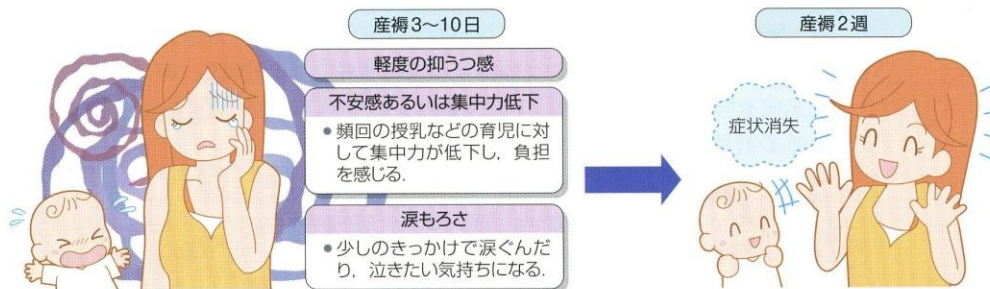
生理的なものと病的なものがある

産褥期における精神障害

- 産褥婦では、分娩による内分泌を中心とした母体生理機能の激変と、母親になったことによる環境変化や育児に伴う疲労などの諸要因が相まって、精神衛生面においても不安定になりやすく精神障害を生じやすい。
- 産褥期に問題となる精神障害には、マタニティーブルーズと産褥期精神病がある。

マタニティーブルーズ

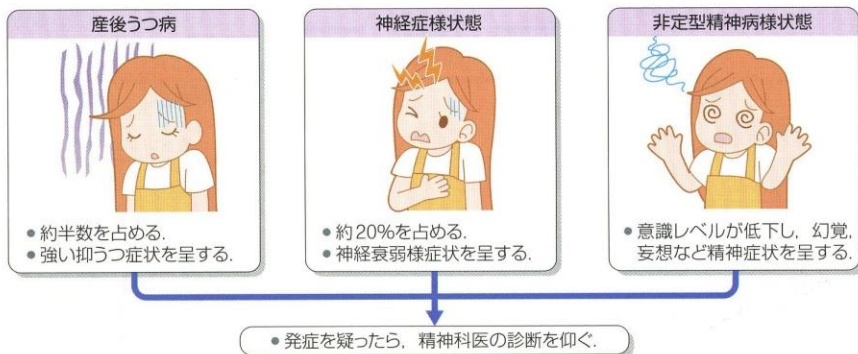
- 産褥3～10日に発症する、一過性の軽い抑うつ状態をいう。
- 症状は軽度で通常2週間ほどで消失する。



- マタニティーブルーズは生理的なものであるため治療は必要とせず、いわゆる「疾病」として扱われる産褥期精神病とは区別される。
- しかし、マタニティーブルーズの症状が重症化すると、産褥期精神病の1つである産後うつ病に移行することがある。

産褥期精神病

- 多くは産褥1カ月以内に発症する。
- 不眠、不安、気分変調、食欲不振などの前駆症状にひき続いて発症することが多い。
- 産褥期精神病は大きく以下の3つに分類される。



- 産後うつ病が重症化すると、非定型精神病様状態に移行する。
- Sheehan 症候群などの分娩・産褥期の出血による脳循環不全が、精神症状の発現の原因となることがある。

産褥期精神疾患



- マタニティーブルーズ
産後3～10日頃
- 産褥うつ病
産後1か月頃～数か月



マタニティブルーズ



産後3～7日頃にみられる一過性の抑うつ状態

30％程度に見られる

(不安感、不眠、涙もろさ、集中力低下)

通常軽度で2週間ほどで消失

しかし、5％程度が産後うつ病に移行する

産後うつ病

10～15％に見られる

産後数か月以内に発症（好発は4週以内）

産後1か月は14％にみられる

抑うつ気分、不安、焦燥、不眠、自責、育児への不安・
恐怖、重症化すると自殺

妊産婦死亡における自殺の割合が多い

母子心中や嬰兒殺し、虐待に関連することがある

母子・家族関係や長期的な子どもの情緒や発達に影響

精神科医の診断を仰ぐ

妊産婦メンタルヘルスのスクリーニングの必要性

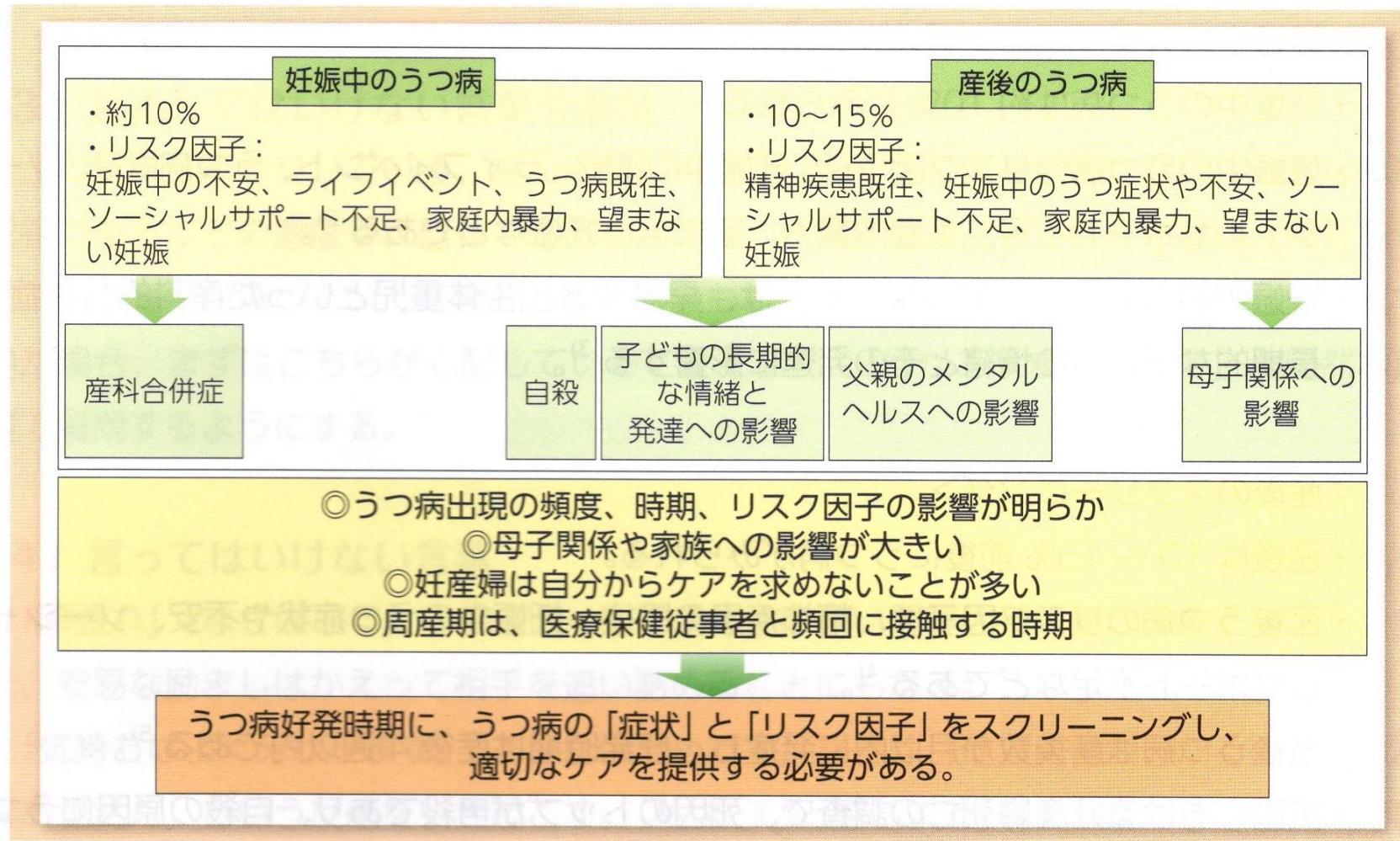


図1. 妊産婦メンタルヘルスのスクリーニングの必要性

産後うつ病



エディンバラ産後うつ病自己調査票
(EPDS)

日本：9点以上でうつ病の可能性が高い

本人に結果の良否は決して伝えない

主に産後2週間健診、1か月健診で行う

エジンバラ産後うつ病質問票 (EPDS)

母氏名 _____ 実施日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (産後 _____ 日目)

産後の気分についておたずねします。あなたも赤ちゃんもお元気ですか。

最近のあなたの気分をチェックしてみましょう。今日だけでなく、過去7日間にあなたが感じたことに最も近い答えに○をつけて下さい。必ず10項目全部答えて下さい。

1) 笑うことができたし、物事のおもしろい面もわかった。

- ☐ () いつもと同様にできた。
- ☐ () あまりできなかった。
- ☐ () 明らかにできなかった。
- ☐ () 全くできなかった。

2) 物事を楽しみにして待った。

- ☐ () いつもと同様にできた。
- ☐ () あまりできなかった。
- ☐ () 明らかにできなかった。
- ☐ () ほとんどできなかった。

3) 物事が悪くいった時、自分を不必要に責めた。

- ☐ () はい、たいていそうだった。
- ☐ () はい、時々そうだった。
- ☐ () いいえ、あまり度々ではなかった。
- ☐ () いいえ、全くなかった。

4) はっきりした理由もないのに不安になったり、心配したりした。

- ☐ () いいえ、そうではなかった。
- ☐ () ほとんどそうではなかった。
- ☐ () はい、時々あった。
- ☐ () はい、しょっちゅうあった。

5) はっきりした理由もないのに恐怖に襲われた。

- ☐ () はい、しょっちゅうあった。
- ☐ () はい、時々あった。
- ☐ () いいえ、めったになかった。
- ☐ () いいえ、全くなかった。

6) することがたくさんあって大変だった。

- ☐ () はい、たいてい対処できなかった。
- ☐ () はい、いつものようにうまく対処できなかった。
- ☐ () いいえ、たいていうまく対処した。
- ☐ () いいえ、普段通りに対処した。

7) 不幸せなので、眠りにくかった。

- ☐ () はい、ほとんどいつもそうだった。
- ☐ () はい、時々そうだった。
- ☐ () いいえ、あまり度々ではなかった。
- ☐ () いいえ、全くなかった。

8) 悲しくなったり、惨めになったりした。

- ☐ () はい、たいていそうだった。
- ☐ () はい、かなりしばしばそうであった。
- ☐ () いいえ、あまり度々ではなかった。
- ☐ () いいえ、全くそうではなかった。

9) 不幸せなので、泣けてきた。

- ☐ () はい、たいていそうだった。
- ☐ () はい、かなりしばしばそうだった。
- ☐ () ほんの時々あった。
- ☐ () いいえ、全くそうではなかった。

10) 自分自身を傷つけるという考えが浮かんできた。

- ☐ () はい、かなりしばしばそうだった。
- ☐ () 時々そうだった。
- ☐ () めったになかった。
- ☐ () 全くなかった。



赤ちゃんへの気持ち質問票

点数が高いほど子供への否定的な感情が強いことを示す
(結果の良否は伝えない)

合計点が3点以上つければ注意

育児に対する気持ちを話してもらい傾聴する
質問3と5は1点以上ついた場合は虐待傾向を疑う

育児支援者の確認、育児負担の軽減を検討

子どもの安全が危惧される場合には児童相談所または市町村
の担当課に通告、要保護児童対策地域協議会で連携した支援
を行う

赤ちゃんへの気持ち質問票

母氏名 _____ 実施日 年 月 日 (産後 日目)

あなたの赤ちゃんについてどのように感じていますか？

下にあげているそれぞれについて、いまのあなたの気持ちにいちばん近いと感じられる表現に○をつけて下さい。

	ほとんどいつも 強くそう感じる	たまに強く そう感じる	たまに少し そう感じる	全然 そう感じない
1) 赤ちゃんをいとおしいと感じる。	()	()	()	()
2) 赤ちゃんのためにしないといけないことがあるのに、おろおろしてどうしていいかわからない時がある。	()	()	()	()
3) 赤ちゃんのことが腹立たしくいやになる。	()	()	()	()
4) 赤ちゃんに対して何も特別な気持ちがわからない。	()	()	()	()
5) 赤ちゃんに対して怒りがこみあげる	()	()	()	()
6) 赤ちゃんの世話を楽しみながらしている。	()	()	()	()
7) こんな子でなかったらなあと思う。	()	()	()	()
8) 赤ちゃんを守ってあげたいと感じる。	()	()	()	()
9) この子がいなかったらなあと思う。	()	()	()	()
10) 赤ちゃんをととても身近に感じる。	()	()	()	()



CQ315 産褥精神障害の取り扱いは？

CQ315 産褥精神障害の取り扱いは？

Answer

1. 産褥期には、精神症状と妊娠中のリスク評価（CQ011 参照）を参考にしながら、精神障害の発生に注意する。(B)
2. 診断・治療に際しては、精神疾患に関する知識・経験が豊富な医師に必要な応じて相談し、精神面への継続的支援体制の構築（医療・行政を含めた）を検討する。(C)
3. 薬剤の大半は授乳可能（CQ104-5 参照）だが、母乳育児が原疾患悪化（寝不足等により）を来す可能性が高い場合には授乳中止を勧める。(C)

CQ011 妊娠中の精神障害のリスク評価の方法は？

Answer

1. 初診時に、精神疾患の既往の有無について情報を得る（CQ002 参照）。(B)
2. 妊娠中に、うつ病と不安障害の発症リスクを判断する。(C)
3. 精神疾患の既往があるか、あるいは 2. でリスクが見込まれ、かつ、家事その他の生活機能が著しく損なわれている状況（重度精神障害の疑い）、あるいは育児困難の状況と考えられる場合には、精神科医への紹介や地域の保健師、社会福祉士あるいは福祉行政窓口への連絡を考慮する。(C)

分娩がゴール！！

ではありません。

お母さん（褥婦）は、
体調もまだ十分ではなく、
おなかも痛いし（後陣痛）、
出血もあるし（悪露）、
眠れないし、気分は落ち込むし（マタニティブルーズ、
産後うつ）、、、。



心身共に健康に過ごせるよう

十分なサポートや環境を各部署と連携して提供することが大事